

Infección por *Listeria monocytogenes*

A quién le da y por qué alimentos · Meningitis y romboencefalitis · Por qué las cefalosporinas no sirven

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: LCR: líquido cefalorraquídeo · SNC: sistema nervioso central · TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol) · ISP: Instituto de Salud Pública · PCR: reacción de polimerasa en cadena · TNF: factor de necrosis tumoral · RM: resonancia magnética.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA/ESCMID de meningitis bacteriana, recomendaciones de la OMS y la FDA/CDC sobre listeriosis alimentaria, y la normativa chilena de vigilancia (MINSAL/ISP). **La listeriosis es una enfermedad de notificación obligatoria en Chile: verificar la norma vigente.**

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Microbiología
3. Epidemiología y grupos de riesgo
4. Fuentes alimentarias
5. Formas clínicas
6. Diagnóstico
7. Tratamiento
8. Listeriosis y embarazo
9. Prevención y salud pública
10. Errores frecuentes
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

Dos hechos explican casi todo lo importante de *Listeria*:

1. **Es un patógeno intracelular facultativo** cuyo control depende de la **inmunidad celular** (linfocitos T y macrófagos). Por eso afecta a **embarazadas, recién nacidos, mayores de 65 años, pacientes con inmunosupresión celular** (corticoides, inhibidores de calcineurina, anti-TNF, trasplantados, neoplasias hematológicas, VIH avanzado, cirrosis, insuficiencia renal crónica) — y **no** a adultos jóvenes inmunocompetentes.
2. **Es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas.** De ahí que el esquema empírico de meningitis bacteriana **agregue ampicilina** cuando el paciente pertenece a un grupo de riesgo.

Regla que hay que memorizar. Meningitis + edad > 50 años, embarazo o inmunosupresión -> agregar ampicilina al esquema empírico (ceftriaxona + vancomicina + **ampicilina** ± dexametasona).

2. Microbiología

- **Bacilo grampositivo pequeño**, no esporulado, **catalasa positivo**, con **motilidad "en paraguas" o tumbling** a 20-25 °C.
- **beta-hemólisis débil** en agar sangre; puede confundirse en la tinción con difteroides ("contaminante") o, si se ve en cadenas cortas, con neumococo o enterococo.
- **Crece a temperatura de refrigeración (4 °C)** — "enriquecimiento en frío" — lo que explica su capacidad de multiplicarse en alimentos refrigerados.
- Tolera sal y pH variables; se destruye con **coCCIÓN adecuada y pasteurización**.

Callout de laboratorio. Un "bacilo grampositivo" informado como probable contaminante en un hemocultivo o en LCR de un paciente de riesgo debe hacer pensar en *Listeria* antes de descartarlo. Conviene comunicarse con el laboratorio.

3. Epidemiología y grupos de riesgo

Grupo	Riesgo relativo y forma clínica típica
Embarazadas (sobre todo tercer trimestre)	Riesgo muy aumentado; síndrome febril inespecífico en la madre, con riesgo grave para el feto
Recién nacidos	Sepsis precoz (granulomatosis infantiséptica) o meningitis tardía
Mayores de 65 años	Bacteriemia y meningitis
Inmunosupresión celular	Corticoides sistémicos, trasplante, anti-TNF, quimioterapia, neoplasias hematológicas, VIH avanzado
Comorbilidad crónica	Cirrosis, insuficiencia renal crónica y diálisis, diabetes, hemocromatosis (sobrecarga de hierro), alcoholismo
Uso de inhibidores de bomba de protones o antiácidos	Factor de riesgo descrito (pérdida de la barrera gástrica)

Presentación **esporádica** o en **brotes alimentarios**, que son los que motivan la investigación epidemiológica y las alertas sanitarias.

4. Fuentes alimentarias

Alimentos **listos para consumir**, refrigerados y no recocinados:

- **Quesos blandos y frescos, especialmente los elaborados con leche no pasteurizada** (tipo brie, camembert, azules, quesillo, quesos frescos artesanales).
- **Leche cruda** y derivados no pasteurizados.
- **Cecinas, patés, jamones y fiambres** (embutidos "listos para comer"); **salmón y pescados ahumados en frío; mariscos crudos**.
- **Verduras y frutas crudas mal lavadas**, brotes germinados, ensaladas envasadas, melón cortado.
- **Helados y productos lácteos artesanales**.

Contexto chileno. Chile ha tenido brotes de listeriosis asociados a **quesos y a productos cárnicos listos para consumir**, con retiros de producto dispuestos por la autoridad sanitaria. La vigilancia de listeriosis está a cargo del **MINSAL** con confirmación y **genotipificación en el ISP. Verificar las alertas y la normativa vigente.**

5. Formas clínicas

5.1 Gastroenteritis febril

- **Persona inmunocompetente**, brote alimentario, incubación corta (**horas a 2-3 días**).
- Fiebre, diarrea acuosa, mialgias, cefalea. **Autolimitada**; habitualmente **no requiere antibiótico** ni se diagnostica (el coprocultivo estándar no busca *Listeria*).

5.2 Bacteriemia sin foco

- La forma **más frecuente en el adulto no embarazado**.
- Fiebre y compromiso del estado general en un paciente de riesgo. **Los hemocultivos son la clave diagnóstica.**

5.3 Infección del sistema nervioso central

Meningitis:

- **Tercera a cuarta causa de meningitis bacteriana del adulto**, con especial peso en > 50 años e inmunosuprimidos.
- **Presentación con frecuencia subaguda y menos florida** que la neumocócica: puede faltar la rigidez de nuca; son comunes las **convulsiones y el compromiso de conciencia**.

- LCR: **pleocitosis que puede ser de predominio mononuclear** (hasta un tercio de los casos), **glucosa a menudo normal o poco descendida**, proteínas elevadas. **La tinción de Gram es positiva en menos de la mitad de los casos**. Este perfil "intermedio" hace que se confunda con meningitis viral o tuberculosa.

Romboencefalitis (encefalitis del tronco):

- **Forma característica y casi patognomónica de *Listeria***. Puede ocurrir en **personas previamente sanas**.
- Curso **bifásico**: pródromo de fiebre, cefalea, náuseas y vómitos por unos días, seguido de **compromiso de pares craneanos (asimétrico), ataxia cerebelosa, disartria, nistagmo, hemiparesia** y depresión de conciencia.
- **La RM es el examen de elección** (muestra realce y lesiones en tronco y cerebelo); la TC suele ser normal.
- **El LCR puede ser poco alterado y los cultivos de LCR frecuentemente negativos: los hemocultivos rinden más.**

Absceso cerebral: raro (~10 % de las infecciones del SNC por *Listeria*), a menudo con bacteriemia asociada; sospechar ante lesiones subcorticales, tálamo o protuberancia.

5.4 Formas focales infrecuentes

Endocarditis (sobre válvula protésica o nativa dañada), peritonitis bacteriana espontánea en cirrótico, infección de prótesis articular o vascular, endoftalmítis, osteomielitis, hepatitis granulomatosa y absceso hepático.

6. Diagnóstico

Muestra	Rendimiento y comentario
Hemocultivos	Fundamentales . Positivos en la mayoría de las bacteriemias, en la listeriosis del embarazo y en buena parte de la romboencefalitis
Cultivo de LCR	Positivo en la mayoría de las meningitis, pero con frecuencia negativo en la romboencefalitis
Gram de LCR	Positivo en menos del 50 % — una tinción negativa no descarta
Paneles moleculares de meningoencefalitis (PCR múltiple)	Incluyen <i>L. monocytogenes</i> ; útiles y rápidos, pero un resultado negativo no descarta cuando la sospecha clínica es alta
Cultivo de placenta, loquios o líquido amniótico; hemocultivo del recién nacido	En sospecha de listeriosis del embarazo
Coprocultivo	No se hace de rutina ni sirve para el diagnóstico individual: requiere medios y solicitud específicos
Serología	No tiene utilidad clínica . No pedirla
RM de encéfalo	Examen de elección ante sospecha de romboencefalitis

Callout. En un paciente > 50 años o inmunosuprimido con meningitis de LCR "atípico" (mononuclear, glucosa normal) o con signos de tronco, hay que pensar en *Listeria* y cubrirla empíricamente, aun sin confirmación microbiológica.

7. Tratamiento

7.1 Elección

Situación	Esquema
De elección	Ampicilina endovenosa en dosis altas (habitualmente 2 g cada 4 horas , es decir 12 g/día en el adulto con función renal normal)
Sinergia en enfermedad grave	Agregar gentamicina las primeras 1-2 semanas en meningitis, romboencefalitis o endocarditis (sinergia demostrada in vitro ; el beneficio clínico es discutido y debe balancearse con la nefro y ototoxicidad, especialmente en el adulto mayor)
Alergia grave a betalactámicos	Cotrimoxazol endovenoso en dosis altas (dosificado por trimetoprim, habitualmente 10-20 mg/kg/día repartido cada 6-8 horas) — buena penetración al SNC
Alternativas de segunda línea	Meropenem (actividad presente pero con reportes de fracaso en SNC), linezolid; decidir con infectología

7.2 Duración orientadora

Forma clínica	Duración
Bacteriemia sin foco	2 semanas (algunos autores 2-3)
Meningitis	3 semanas (mínimo 21 días)
Romboencefalitis y absceso cerebral	>= 6 semanas
Endocarditis	4-6 semanas
Inmunocomprometido	Extender según respuesta clínica

7.3 Lo que NO sirve

- **Todas las cefalosporinas** (incluidas ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima): *Listeria* es **intrínsecamente resistente**.
- **Fosfomicina** y **clindamicina** no son opciones fiables.
- Las **fluoroquinolonas** tienen actividad in vitro pero evidencia clínica insuficiente en SNC.

7.4 Sobre la dexametasona

En meningitis bacteriana del adulto se recomienda dexametasona antes o con la primera dosis de antibiótico por el beneficio demostrado en **neumococo**. Cuando se confirma *Listeria*, **la dexametasona no ha mostrado beneficio y algunos estudios observacionales sugieren peor evolución**, por lo que **se suspende** una vez identificado el agente. **Verificar la recomendación vigente y el protocolo institucional.**

8. Listeriosis y embarazo

- La embarazada presenta típicamente un **síndrome febril inespecífico** ("cuadro gripal") con o sin síntomas gastrointestinales, **sin meningitis**. La sospecha exige **hemocultivos**: son el examen clave.
- **Consecuencias fetales**: aborto, muerte fetal in utero, parto prematuro, corioamnionitis, **sepsis neonatal precoz** (granulomatosis infantiséptica, con microabscesos diseminados) o **meningitis neonatal tardía**.
- **Tratamiento: ampicilina endovenosa en dosis altas**; en alergia, discutir con infectología y obstetricia (cotrimoxazol se evita en el primer trimestre y cerca del término). **Iniciar precozmente ante sospecha: el tratamiento oportuno mejora el pronóstico fetal.**
- **La gentamicina se evita en el embarazo** salvo indicación imperiosa (ototoxicidad fetal).
- **Conducta ante exposición alimentaria en embarazada asintomática**: habitualmente **observación**, sin cultivos ni antibióticos; si aparece fiebre, **hemocultivos e inicio de tratamiento. Verificar la recomendación vigente.**

9. Prevención y salud pública

Consejería a grupos de riesgo (embarazadas, inmunosuprimidos, mayores de 65 años):

- **Evitar** quesos blandos y frescos de leche no pasteurizada, leche cruda, patés y fiambres refrigerados no recalentados, pescados ahumados en frío, brotes germinados y ensaladas envasadas listas para consumir.
- **Recalentar hasta humear (>= 74 °C)** las cecinas y fiambres antes de consumirlos.
- Lavar prolijamente frutas y verduras; separar alimentos crudos de cocidos; mantener el refrigerador a <= 4 °C y limpiarlo con regularidad; respetar las fechas de vencimiento.

Vigilancia:

- La **listeriosis es de notificación obligatoria en Chile**; la confirmación y la **genotipificación (secuenciación)** se realizan en el **ISP**, lo que permite vincular casos y detectar brotes de origen alimentario.
- Ante un caso confirmado, **notificar a la SEREMI de Salud** e indagar el antecedente alimentario. **Verificar la normativa vigente.**

10. Errores frecuentes

1. **No agregar ampicilina** al esquema empírico de meningitis en > 50 años, embarazadas o inmunosuprimidos.
2. Descartar el diagnóstico porque el **LCR es mononuclear con glucosa normal**.

3. Descartarlo porque el **Gram de LCR es negativo**.
 4. Informar el bacilo grampositivo del hemocultivo como "**contaminante difterioide**" y no avisar.
 5. Tratar con **ceftriaxona** creyendo que cubre *Listeria*.
 6. **Pedir serología** de *Listeria*: no existe una prueba serológica útil.
 7. **Esperar el coprocultivo**: no rinde para el diagnóstico individual.
 8. Tratar una meningitis por *Listeria* **solo 10-14 días**: se necesitan al menos 3 semanas, y ≥ 6 en romboencefalitis o absceso.
 9. **Mantener dexametasona** una vez confirmada la listeriosis.
 10. En una embarazada con fiebre sin foco, **no tomar hemocultivos**.
 11. **No notificar** el caso ni indagar la fuente alimentaria.
-

11. Perlas de alto rendimiento

- *Listeria* es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas.
 - Meningitis + > 50 años / embarazo / inmunosupresión -> ampicilina empírica.
 - Romboencefalitis (compromiso de tronco, ataxia, pares craneanos) = *Listeria* hasta demostrar lo contrario, incluso en inmunocompetentes; la RM es el examen y los hemocultivos rinden más que el LCR.
 - Bacilo grampositivo con motilidad "en paraguas" que crece a 4 °C.
 - El LCR puede ser mononuclear con glucosa normal: no descarta.
 - Embarazada con fiebre sin foco -> hemocultivos y pensar en *Listeria*.
 - Ampicilina en dosis altas es el tratamiento; cotrimoxazol si alergia grave.
 - Duraciones: bacteriemia 2 semanas, meningitis 3, romboencefalitis y absceso ≥ 6 .
 - Enfermedad de notificación obligatoria con confirmación en el ISP.
-

12. Bibliografía esencial

1. Tunkel AR, et al. *Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis*. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis (versión vigente) y Tunkel AR, et al. 2017 IDSA Clinical Practice Guidelines for Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis.
 2. van de Beek D, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect 2016;22(Suppl 3):S37-S62.
 3. Charlier C, et al. (MONALISA study). Clinical features and prognostic factors of listeriosis: the MONALISA national prospective cohort study. Lancet Infect Dis 2017;17:510-519.
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Listeria (Listeriosis)*: información clínica y de prevención alimentaria.
 5. MINSAL, Chile. Circulares de vigilancia epidemiológica de listeriosis y decreto de enfermedades de notificación obligatoria. Verificar la versión vigente.
 6. Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). Laboratorio de referencia: confirmación y genotipificación de *Listeria monocytogenes*.
 7. UpToDate. Temas: *Clinical manifestations and diagnosis of Listeria monocytogenes infection, Treatment and prevention of Listeria monocytogenes infection*.
 8. MKSAP (American College of Physicians). Sección de Enfermedades Infecciosas: meningitis bacteriana y patógenos transmitidos por alimentos.
-

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS.